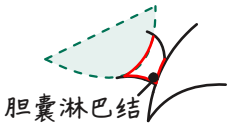
患者当出现过一次胆绞痛后,一年后会再次发作

（三）胆囊结石的治疗

1.**有症状**的胆囊结石——**腹腔镜胆囊切除术 LC** 易导致医源性胆管损伤,多损伤胆囊管和肝总管汇合的位置

①准确识别胆囊/Calot 三角以确认胆囊动脉的位置。胆囊三角由**胆囊管、肝总管、肝脏下缘**构成，含有胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管 囊右右



②术中过度牵拉胆囊致迷走神经受激惹→胆心反射、甚至心搏骤停

③小胆囊结石需探查胆总管

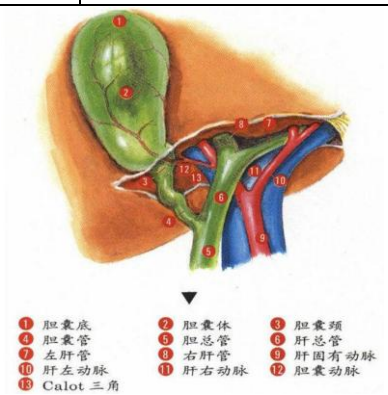
2.无症状的胆囊结石

①观察

病例题看大小,多选题选项有结石数量多是对的

②**预防性腹腔镜胆囊切除术**的适应症（123 盖茨慢糖心）：

胆囊内	结石数量多及**≥2-3**cm、伴胆囊**息肉≥1**cm 2cm以上的结石易癌变,3cm以上易嵌顿
胆囊壁	**慢性胆囊炎**（胆囊壁＞3mm）、**瓷性胆囊**（胆囊壁钙化）胆囊已经没用了
全身	糖尿病、心肺功能障碍 糖尿病抵抗力差,在无症状时尽早切掉





瓷性胆囊(像陶瓷一样)

三、急性胆囊炎

（一）急性结石性胆囊炎 梗阻、细菌排不走继发感染

1.典型表现

①持续性胆绞痛（右上腹痛）伴阵发加剧

②发热、WBC↑

③**Murphy 征（右上腹触及疼痛、肿大的胆囊）**VS courvoisier征:无痛肿大的胆囊

④**多无黄疸**（仅 10-20%有轻度黄疸）

eg.中下段胆管癌、胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌



2.病程 类比阑尾炎 关注原发部位:阑尾炎的疼痛(右下腹),胆囊炎的疼痛(右上腹)

①单纯性胆囊炎

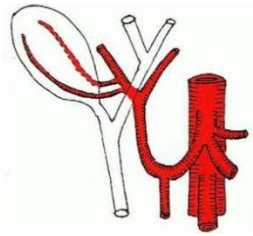
②化脓性胆囊炎：寒战高热、局限性**腹膜炎**（局部压痛/反跳痛/肌紧张）、胆囊积脓

③坏疽穿孔性胆囊炎（好发于胆囊底、颈部）：弥漫性腹膜炎（全腹压痛/反跳痛/肌紧张）

递进

④边界不清的固定压痛肿块：发炎的胆囊被大网膜包裹

胆囊周围脓肿



3.手术治疗

①**≤3 天：急诊腹腔镜胆囊切除术** VS PTCD经皮经肝胆管穿刺引流

②**＞3 天：急诊 PTGD（经皮经肝胆囊穿刺引流）或胆囊造口，3 个月后腹腔镜胆囊切除术**

VS 阑尾周围脓肿:先引流,三个月后切阑尾